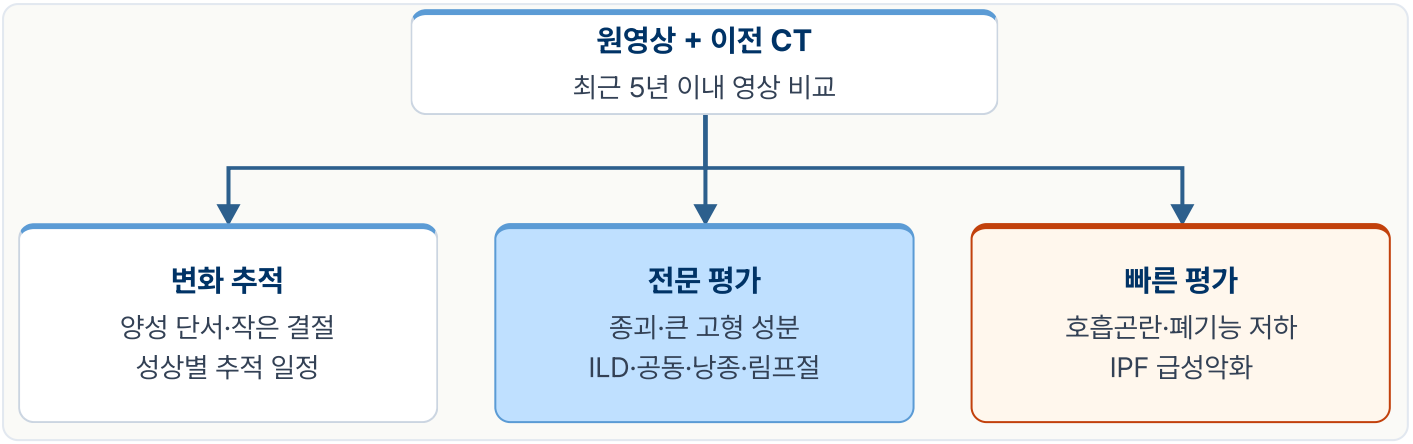
의료진 진료 카드 · ASL-065

흉부 CT · 추적과 의뢰

원영상·이전 영상을 비교하고 결절, 간질성 변화, 공동·낭종·림프절을 구분한다. 강의의 경로 요약.

CT 소견별로 다른 경로를 선택



우선 구분할 CT 소견

Consolidation	기관지는 보이나 혈관이 보이지 않는 폐경화. 강의는 폐렴이 흔해 항생제 치료 후 반응을 보도록 설명.
Mass	혈관·기관지가 가려지는 종괴 양상은 암 가능성을 고려해 바로 조직검사 가능한 병원에 의뢰한다는 설명.
GGO	혈관·기관지가 모두 보이는 간유리음영. 작으면 추적, 크거나 고형성분이 생기면 추가 평가. 결절별 기준은 다음 쪽.
ILD/IPF	GGO·망상음영·벌집모양, 견인성 기관지확장 등이 섞인 전반적 병변은 의뢰. 급작스러운 전폐 악화는 중환자실 치료가 필요할 정도로 심각하다고 설명.

연자 Q&A · ILA와 검사 연결

작은 ILA	검진 주기 또는 약 1년 CT 추적. 본강의는 6개월~1년 추적 후 진행하면 의뢰하는 경로를 소개.
ILD의 빠른 진료	증상이 있거나 특정 질환 감별이 필요하면 호흡기내과 진료. 특히 호흡곤란·폐기능 저하가 있으면 빨리 진료받도록 답변.
CT가 어려운 의원	연자는 CXR이 정상이어도 폐암을 배제하지 못하고, 폐암 평가에는 CT가 맞다고 설명. X-ray AI 이상 표지만으로 암을 확정하지 않고 원영상과 과거 사진을 확인.

영상 판독을 그대로 한 가지 추적 주기로 통일하지 않는다. 병변 성상·크기·성장과 환자의 증상·폐기능을 함께 보고, 강의의 각 경로에 따라 추적 또는 의뢰한다.

의료진 진료 카드 · ASL-065

폐결절 · 범주와 성상별 추적

강의의 Lung-RADS v1.0 범주표와 별도 병변별 도식. 새로운 결절·성장·고형성분을 함께 확인한다.

교재 범주표 · Lung-RADS v1.0

1·2	1: 결절 없음 또는 확실한 양성. 2: 암 가능성 낮은 양성 결절. 12개월 후 연례 검진 CT.
3·4A	3: 양성 추정이지만 6개월 추적. 4A: 폐암 의심으로 3개월 추적.
4B·4X·S	4B·4X: 매우 의심, 추가검사·상급병원 평가. S: 결절 외 흉부질환으로 추가 진료. 여러 범주가 공존하면 가장 의심되는 높은 범주 채택.
측정·비교	장·단축 평균 직경, lung window에서 mm 정수 보고. 최근 5년 이내 CT 비교, 새 발생 여부와 >1.5mm 성장 확인.

교재·본강의 · 병변별 도식

고형 결절	<8mm: 약 6개월 후 추적. ≥8mm: 3개월 추적 후 변화에 따라 조직검사±PET/CT·수술 평가. 연자는 커지면 의뢰하도록 설명.
부분고형 결절	3개월 CT 후 고형성분 크기로 분기. 고형성분 <8mm는 6개월·12개월 추적, ≥8mm는 수술 또는 생검 평가 의뢰.
순수 GGO	3개월 CT 후 소실하면 통상 검진. 지속 시 <15mm는 6개월·12개월 추적, ≥15mm는 수술/생검 여부 상담 의뢰.
양성 단서	중심성·미만성·층상·팝콘형 석회화, 지방 포함 결절, 엽간열 림프절은 양성 가능성. 엽간열 침범·주변 결절·변화를 함께 판단하며 CT 모양만으로 최종 암 진단을 대신하지 않는다.

본강의 · 병변의 구조를 먼저 본다

고형·부분고형

부분고형은 가운데 고형성분과 주변 GGO. 연자는 부분고형부터 의뢰를 고려하고, 별도 도식에서는 고형성분 8mm로 분기했다.

순수 간유리

혈관이 비쳐 보이는 병변. 초기 폐선암 스펙트럼과 연관될 수 있지만 일시적 음영도 있어 3개월 소실·지속 여부를 본다.

범주화는 가장 의심되는 결절을 기준으로 한다. 추적 CT에서 크기·고형성분·새 발생을 비교하고, 병변 특성에 맞춰 개별 접근한다.

의료진 진료 카드 · ASL-065

결절 밖 CT 소견 · 의뢰 단서

공동·낭종·림프절·간질성 음영은 폐결절 크기 기준과 별개의 평가가 필요하다.

본강의 · 공동·다발 낭종·림프절

NTM 양상	결핵과 유사하나 전염되지 않는 비결핵항산균. 작은 딸결절이 동반될 수 있고 공동이 있거나 진행할 때 치료를 고려하므로 해당 소견은 의뢰.
다발 낭종	심한 폐기종은 COPD 평가·치료. 얇은 벽 다발 낭종은 LAM, 두꺼운 벽 다발 낭종은 Langerhans cell histiocytosis 등 드문 질환 가능성으로 의뢰.
종격동 림프절	기관·기관지 옆, 양측 폐문·혈관 사이 림프절 비대는 내시경 조직검사로 원인 확인이 가능하므로 의뢰.
Sarcoidosis·전이	림프절 비대·폐 침윤의 sarcoidosis, 그물·좁쌀형 전이 가능성은 전문 평가. BOOP/COP·약제유발 ILD·과민성 폐렴 등도 감별 의뢰.

본강의 · 혈관성·감염성 소견

폐동정맥기형	feeding vessel이 보이는 혈관성 병변을 pulmonary AVM으로 설명. 연자는 3~6개월 CT로 변화 확인 후 정기 검진 관찰 경로를 제시했다. 이를 일반 양성 고형결절과 같은 병변으로 표시하지 않는다.
결핵·객혈	결핵 패턴은 객담검사로 균 확인·치료. 객혈은 기관지확장증·양성종양·결핵·암이 가능해 CT 평가 후 의뢰. 면역저하자의 PCP 폐렴도 감별.
ILA의 정의	교재는 비의존성 우연 이상 소견으로 한 폐영역의 최소 5% 침범을 제시. 비흉막하 비섬유성·흉막하 비섬유성·흉막하 섬유성으로 분류.
진행 평가	본강의는 ILA 유병 약 7~10%, 진행 20~73%, 사망 Hazard ratio 1.3~2.7의 연구들을 소개. 2년 후 벌집·망상음영으로 진행한 사례를 제시했다.

연자 Q&A: 증상이 있거나 ILD 감별이 필요한 경우 호흡기내과 평가를 연결한다. 영상이 조금이라는 이유만으로 호흡곤란이나 폐기능 저하 환자의 진료를 미루지 않는다.